

AFMCP Chap6 패널: 자가면역 임상 진주 — 핵심 요약

1. 기능의학 접근이 잘 맞는 자가면역 질환

- 하시모토 갑상선염, 그레이브스병, 염증성 장질환(IBD)
- 장 먼저 치료 → 염증성 장 질환 역전 기회 ↑
- 자가면역 갑상선염 = 첫 번째로 나타나는 자가면역 과정 → 조기 발견·역전 가능

2. 핵심 치료 전략

식이:

- 간헐적 단식 (1개월 시험, 핸드아웃 제공)
- 인슐린 스파이크 최소화
- 트리거 식품 제거 (초가공식품, 식이 유화제)

생활습관:

- 스트레스 관리 — 가장 어려운 과제
- 운동 재개 (주 3회+)
- 수면 7시간+, HRV 모니터링

장 건강:

- SIBO/칸디다 치료 (허브+약물 옵션)
- 소화 효소 지원
- 장부터 시작 — 자가면역 환자 모두 DIG IN 기능 이상 동반

3. 반드시 탐색할 영역

- 외상 이력 (ACE): 접수 양식에 포함 — 외상 → 10년 후 자가면역 패턴
- 독소 노출: 곰팡이, 생활/직업 환경 독소
- 매트릭스 모든 노드 탐색: 심리사회적, 독소, 미토콘드리아 등

4. 임상 진주 (Pearls)

- 기대치 설정: '18개월 과정' 솔직하게 전달
- 약물은 '다리(bridge)' — 호전되면 단계적 감량
- 기능의학 ≠ 전통 의학 대체 — 상호 보완적으로 활용
- 간헐적 단식 도입 시 영양 전문가 협진
- 치유 지향적 계획 = 환자에게 희망과 통제감 회복